1
GENERALITĂŢI

1 : INTRODUCERE

1.1 Despre această carte

Această carte a fost scrisă pentru medicii care nu sînt pneumologi, pentru medici care lucrează în asistenţa medicală primară şi alte cadre medicale din domeniul sănătăţii care ar putea întîlni tuberculoza în activitatea lor. Aproape toţi pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză pot fi vindecaţi dacă sunt trataţi corect. Mulţi vor muri dacă nu sunt trataţi corect. De aceea, ca medic sau cadru medical responsabil

- NU greşiţi diagnosticul
- TRATAŢI apoi corect şi pe întreaga perioadă.

Mai mult decît atît, TRATAMENTUL CORECT ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ FORMĂ DE PREVENIRE. El face ca pacienţii contagioşi să devină necontagioşi, ceea ce reduce răspîndirea infecţiei în comunitate.
Tuberculoza este o boală care te pune la încercare. Uneori efortul de a pune diagnosticul seamănă cu încercarea de a rezolva o dilemă poliţistă. Dar dacă rezolvi problema cu succes, poţi fi sigur de sfîrşitul fericit al poveştii. Tratamentul modern este foarte eficient în tratarea tuberculozei, chiar şi la pacienţi infectaţi cu HIV.

1.2. Unele lucruri pe care trebuie să le ştiţi

Dacă veţi juca un rol în ajutarea pacienţilor şi controlarea tuberculozei în ţara dvs., va trebui să ştiţi cum majoritatea oamenilor controlează această infecţie şi nu se îmbolnăvesc, în timp ce alţii fac boala. Oamenii se vor aştepta de asemeni ca dvs. să cunoaşteţi şi cea mai bună modalitate de a **preveni** tuberculoza. Dacă ţara dvs. are un **program naţional** pentru controlul tuberculozei, DVS. TREBUIE SĂ-L CUNOAŞTEŢI, şi să contribuiţi la punerea lui în aplicare.

1.3. Problema mondială a tuberculozei

În multe ţări industrializate banii, resursele, nivelul înalt de trai şi răspîndirea largă a chimioterapiei din ultimii 40 de ani au făcut ca tuberculoza să devină o problemă relativ minoră. Dar în ţările mai sărace ea rămîne în continuare o mare problemă. Deoarece populaţiile lor au crescut iar indicii tuberculozei au scăzut foarte puţin, **există probabil astăzi mai mulţi bolnavi de**

tuberculoză în lume decît în urmă cu 20 de ani. Calculele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că în lume sunt probabil 8-10 milioane de cazuri noi pe an, şi 3 milioane de decese. Deoarece este foarte probabil ca pacienţii din ţările cu prevalenţa mare care se infectează cu HIV să dezvolte tuberculoza, ea va deveni chiar şi mai frecventă acolo unde ambele infecţii sînt frecvente. La aceşti pacienţi tuberculoza poate apărea sub forme noi sau neobişnuite (cap5).

1.4. Privire de ansamblu

Toate aceste lucruri pot părea deprimante, dar în mai multe ţări sărace cu indici mari de tuberculoză programele moderne de tratament în masă, aplicate eficient, au dat rezultate excelente. Există chiar semne că în unele dintre aceste ţări, în care infecţia HIV este scăzută, tuberculoza începe să scadă. OMS a estimat recent rata de declin a **riscului anual al infecţiei tuberculoase** în ţările cu prevalenţă mare. Aprecierea s-a făcut prin pozitivitatea reacţiei la tuberculină (care arată desigur **infecţia**, şi nu boala clinică). În ţările din Europa şi America de Nord după introducerea chimioterapiei rata de declin a fost de 10,5 - 14,5% pe an. Cifre recente arată o scădere anuală de 5-10% în multe ţări din America Latină, ţări arabe şi din Pacificul de Vest, 6-7% în anumite zone din ţări asiatice întinse şi 2-4% în unele ţări africane. Acest lucru este încurajator dar mai este încă foarte mult de făcut ; pe deasupra, cifrele ar putea stagna sau creşte în ţările cu mare răspîndire a infecţiei HIV. Infecţia HIV afectează rezistenţa omului la tuberculoză (cap.5).

1.5. Reacţia la tuberculină şi numărul cazurilor noi anuale

S-a calculat că **pentru fiecare 1% de nou infectaţi anual** (indivizi noi tuberculino-pozitivi dintr-o populaţie) **vor fi 50-60 de cazuri noi de tuberculoză pulmonară cu BK pozitiv la examenul microscopic la 100.000 de locuitori şi pe an, şi un număr egal de cazuri de tuberculoză pulmonară cu BK negativ, fie cu localizare extrapulmonară**. Folosind această formulă, se poate utiliza reacţia la tuberculină pentru a calcula numărul probabil de cazuri noi/an într-o ţară.

1.6. Tratamentul

În multe ţări sînt unii doctori care dau **tratament incorect**. Consecinţele cele mai probabile ale acestui fapt sînt :
- pacientul nu se va vindeca
- dezvoltarea de bacili tuberculoşi chimiorezistenţi, greu de tratat ulterior
- pacientul rămîne contagios, probabil cu germeni rezistenţi, şi răspîndeşte boala în jur.

Deci tratamentul incorect înseamnă asistenţă sanitară slabă a individului şi a societăţii.
De aceea în secţiunea a 2-a a acestui capitol vom da unele recomandări generale, utile pentru evitarea greşelilor obişnuite.
Vă sugerăm să le citiţi mai întîi pe acestea, deşi ne dăm seama că dvs. înşivă s-ar putea să nu aveţi nevoie de aceste sfaturi de bază. Continuaţi apoi cu celelalte părţi ale cărţii, care vă oferă mai multe detalii.

2 : LINII DIRECTOARE GENERALE ÎN TRATAMENTUL TUBERCULOZEI

2.1 DA şi NU pentru medici

2.1.1. NU. Evitaţi următoarele erori care sînt obişnuite în unele ţări :

1. Nu trataţi niciodată un pacient cu suspiciune de tuberculoză pulmonară fără **examinarea sputei** (acolo unde se poate face examen microscopic). Copii adesea nu expectorează, iar diagnosticul se pune în special pe elemente clinice.
2. Nu daţi niciodată doar un **singur tuberculostatic** : se instalează de obicei chimiorezistenţa, care este permanentă.
3. Dacă evoluţia pacientului **este nefavorabilă** cu o combinaţie de medicamente, nu adăugaţi niciodată un singur nou medicament. Mai întîi asiguraţi-vă că el ia cu regularitate medicamentele : dacă le ia şi evoluţia este nefavorabilă, bacilii săi sînt rezistenţi la toate medicametele folosite. Adăugarea unui singur medicament în plus este ca şi cum am face tratament cu un singur medicament. Pacientul va căpăta curînd rezistenţă şi la acesta.
4. Urmăriţi întotdeauna pacientul şi asiguraţi-vă că va face întregul tratament recomandat (6 sau 8 luni cu rifampicină în chimioterapia de scurtă durată). Dacă este posibil, asiguraţi-vă ca în primele două luni pacientul ia fiecare doză sub supraveghere (Tratamentul strict supravegheat).
5. Nu folosiţi niciodată o combinaţie de penicilină şi streptomicină pentru afecţiuni netuberculoase. Efectul este rareori mai bun decît al penicilinei singure sau al tetraciclinei, şi se poate instala rezistenţă la streptomicină în cazul în care pacientul are o tuberculoză. Folosiţi rifampicina doar pentru tratarea tuberculozei sau a leprei.
6. Nu trataţi niciodată doar după indicaţiile firmei producătoare de medicamente : ele pot fi părtinitoare şi greşite.

2.1.2. DA. Amintiţi-vă de următoarele reguli importante şi simple :

1. Examinaţi întotdeauna sputa unui caz suspect. Este singura metodă sigură de diagnostic. Dacă sputa este negativă, dar radiografia e sugestivă, repetaţi radiografia peste 3 săptămîni : poate să fie o pneumonie trecătoare (sau abces pulmonar).

2. Folosiţi doar combinaţiile de medicamente recomandate (p. 149) Este periculoasă folosirea de combinaţii medicamentoase neverificate sau cunoscute drept riscante, cînd de fapt toţi pacienţii pot fi vindecaţi prin metodele stabilite.
3. Este foarte important să convingeţi pacientul (şi familia lui) că trebuie să facă tratamentul complet (6 sau 8 luni cu combinaţii ce conţin rifampicină şi pirazinamidă) pentru a evita recăderea. Sunt utile broşurile explicative, şi ar trebui să existe şi în ţara dvs. (Chiar şi în cazul pacienţilor analfabeţi, cineva din familie sau din sat le poate citi broşura).
4. Este esenţial să fiţi plin de bunăvoinţă şi simpatie faţă de pacient. Experienţa a arătat că este mai probabil ca el să revină şi să-şi facă tratamentul complet dacă are încredere în dvs..
5. Amintiţi-vă că datorită omiterii unei luni de tratament, sputa lui poate fi pozitivă, tratamentul trebuie reluat de la început. (Unele programe naţionale au alt regim pentru asemenea pacienţi).
6. Dacă pacientul a primit mai multe serii de tratament anterior (poate cu combinaţii medicamentoase slabe), iar acum are o recădere, trimiteţi-l la specialist (sau cereţi sfatul în scris). Stabilirea tratamentului în astfel de cazuri este dificilă şi o greşeală poate fi fatală. Programul naţional de control al tuberculozei din ţara dvs. poate avea o schemă terapeutică specială pentru astfel de bolnavi.

2.1.3. Atenţionări. Pentru detalii asupra schemelor de tratament recomandate vezi cap. 6. Dar **reţineţi**:

1. **Majoritatea eşecurilor** sau recăderilor se datorează **tratamentului prea scurt**, deoarece medicul sau pacientul nu îşi dă seama de importanţa tratamentului complet şi fără întreruperi.
   Din nefericire alte motive pot fi faptul că un membru al personalului a sustras medicamentele destinate pacientului sau faptul că pacientul a vîndut medicamentele în loc să le ia!
   Alte eşecuri se datorează tratamentului greşit sau discontinuu cu combinaţii necorespunzătoare: un medic slab pregătit a recomandat un tratament prost; sau nu a instruit pacientul ce medicamente să ia şi cînd, şi nu i-a spus despre importanţa de a le lua regulat. În acest caz este posibil să fi apărut **chimiorezistenţa** (vezi p. 144).
2. După tratament prea scurt cu una din schemele principale, este probabil ca bacilii pacientului respectiv să fie **încă chimiosensibili la principalele tuberculosatatice**. Se poate relua astfel tratamentul cu una din **schemele** principale.
3. Dacă consideraţi că trebuie să daţi rifampicină (şi dacă nu este inclusă în programul dvs.naţional):
   a) asiguraţi-vă că pacientul îşi poate permite să facă **tratamentul integral**. Dacă tratamentul e prea scurt, boala va recidiva.

b) daţi una din **schemele terapeutice recomandate** (p. 149). Alte scheme pot da eşecuri, **chimiorezistenţă** sau **recădere precoce**.

2.2. Generalităţi despre tuberculoză pentru asistentele medicale.

Ca medic trebuie să vă asiguraţi că întregul dvs. personal cunoaşte următoarele reguli şi acţionează în conformitate cu ele.

Tuberculoza este vindecabilă
VIAŢA PACIENTULUI DEPINDE DE DVS.

2.2.1. Tuberculoza este o **boală infecţioasă** care se răspîndeşte prin tuse şi spută. De aceea **faceţi tot posibilul să convingeţi oamenii să abandoneze obiceiul scuipatului**.

2.2.2. **Simptomele tuberculozei**. Consideraţi „suspect de tuberculoză" (vezi p. 91) un pacient care prezintă:

- tuse de mai mult de 3 săptămîni
- hemoptizie
- o durere toracică de mai mult de 3 săptămîni
- febră de mai mult de 3 săptămîni

Toate acestea pot apărea şi în alte boli, dar dacă pacientul expectorează, **trebuie examinată sputa**.

2.2.3. **Ne putem baza mai mult pe examenul sputei decît pe examenul radiologic**. Dacă 3 spute sînt **negative**, daţi un tratament nespecific (fără tuberculostatice). Dacă simptomele persistă repetaţi examenul sputei şi/sau apelaţi la un specialist. La copii diagnosticul poate fi dificil (p. 41).

2.2.4. Dacă **sputa este pozitivă**, tuberculoza poate fi uşor tratată dacă pacientul ia întregul tratament (p. 135)

2.2.5. Simptomele dispar repede, dar **tratamentul trebuie continuat cu regularitate pe toată perioada indicată** (vezi p. 138). Altfel boala revine şi tratamentul trebuie luat de la capăt.

2.2.6. Vaccinarea BCG reprezintă o bună protecţie împotriva tuberculozei la copil, în special împotriva formelor fatale de meningită şi miliară tuberculoasă.